

BACK

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Deslumbraamiento significativo y/o halo alrededor de las luces
Descoloración/negatividad de la ICP V2.0
Pérdida de células endoteliales en la ICP V2.0
Laceración/rótura de la ICP V2.0
Pérdida de la mejor agudeza visual corregida con gafas
Intervención quirúrgica secundaria para retirar o reemplazar la ICP V2.0
La implantación de una ICP V2.0 puede provocar una disminución de la densidad de células endoteliales corneales.

ES

Contraindicaciones y advertencias

Pacientes con glaucoma no tratado o implante (ICPL V2.0) está contraindicada en presencia de cualquiera de las siguientes circunstancias u/o condiciones, incluso, entre otras: pacientes con antecedentes u/o signos clínicos de iris, uveítis, queratitis, síndrome de ojo seco, infección ocular, inflamación intraocular, inflamación intraocular crónica, degeneración macular, astigmatismo irregular, quequeroneo óptico o cualquier otro tipo de lesión del ojo.
Pacientes con retinopatía diabética sin controlar o de los ojos.
Pacientes con glaucoma en cualquiera de los ojos.
Pacientes con antecedentes de cirugía intraocular previa (incluida cirugía refractiva) en el ojo que va ser tratado.
Pacientes con amiblogia o cualquier otro tipo de controlateral.
Pacientes que no se encuentren dentro del rango de miopía u/o astigmatismo previo al tratamiento descrito en los criterios.
No incluye este procedimiento en:
Pacientes con una enfermedad progresiva que amenace la visión. Se permiten pacientes con hallazgos retinales asociados
Pacientes con diabetes descontrolada.
Pacientes con enfermedades infecciosas activas.
Pacientes con distrofia de la fucha o una patología celular.
Pacientes con cataratas en cualquiera de los ojos.
Pacientes con una refracción inestable durante los últimos 12 meses (miopía u/o astigmatismo).
Pacientes embarazadas o en periodo de lactancia.
Pacientes con una densidad de células endoteliales corneales bajo a normal.
Pacientes con una profundidad de cámara anterior < 2,8 mm.

¿Es usted un buen candidato para la cirugía ICP V2.0?

Se médico realizará una evaluación oftalmológica detallada para determinar si la cirugía ICP V2.0 es adecuada para usted. Puede ser considerado candidato para esta cirugía si:

- tiene entre 21 y 45 años (para lentes monofocales/tóricas) o entre 40 y 60 años (para lentes para presbiopia).
- tiene una refracción estable por lo menos 3 meses antes de la cirugía (astigmatismo entre +0.50 y -1.50 D (para ICP V2.0) y monofocal e ICP V2.0 tórica y astigmatismo entre +1.00 y +10.0 D (para Presbiópia e ICP V2.0 tórica para Presbiopia).
- presenta astigmatismo (para lentes toricas), cuando corresponde.
- no tiene un diagnóstico específico de ninguna enfermedad ocular que pueda afectar la implementación de la ICP V2.0. Esto es necesario para garantizar que la densidad mínimamente aceptable de la fina capa de células (células endoteliales) situada en la superficie posterior de la córnea, sea suficiente para soportar la cirugía. Si su médico determina que su densidad de células endoteliales está por debajo del nivel mínimo, tendrá un mayor riesgo de desarrollar hinchazón cornea (edema corneal), lo que podría requerir la extracción y sustitución de la córnea (trasplante de córnea).
- carece de evidencia escrita que demuestre que su miopía o hipermetropía ha permanecido estable durante el menor 1 año.
- comprendiendo los beneficios y los riesgos de la cirugía en comparación con otras opciones de tratamiento.
- no tiene alergias conocidas a ninguno de los medicamentos que su médico puede indicar volver a conducir a causa de la cirugía.
- no está embarazada ni en período de lactancia.
- comprende que entre 2 y 3 semanas antes de la cirugía, su médico necesitará realizar pequeños orificios en el borde más externo de la parte exterior de su ojo (donde normalmente se colocan las lentes de contacto) mediante láser.
- está dispuesto a firmar un formulario de consentimiento antes del procedimiento.

Usted y su médico determinarán si es un candidato adecuado para la ICP V2.0 (monofocal, tórica, para presbiopia y tórica para presbiopia), así como la frecuencia de seguimiento necesaria para controlar la salud de su ojo.

¿Qué debe esperar durante la cirugía ICP V2.0?

Antes de la cirugía

El día de la cirugía su médico revisará su historial médico y oftalmológico y le mostrará cómo operar para asegurarse de que están sanos y serán adecuados para la implementación de la ICP V2.0. Esto incluirá la evaluación de la capa interna de la córnea (endotelio). Si sus lentes de contacto, o de uso anteriores entre 2 y 3 semanas antes de la revisión oftalmológica y de la cirugía. Esto ayudo a su médico a obtener mediciones precisas que permitan que su miopía o hipermetropía ha permanecido estable durante el menor 1 año.

Informe a su médico sobre cualquier medicamento que esté tomando, problemas oculares, cirugías oculares previas, afecciones médicas o alergias. Pregunte si debe comer o beber antes de la cirugía. Asimismo, organe con antelación qué alguien le ayude a casa, ya que no debe conducir inmediatamente después del procedimiento. Su médico le indicará cuándo volver a conducir a causa de la cirugía.

Dos a tres semanas antes de la cirugía

Entre dos y tres semanas antes de la cirugía ICP V2.0, su médico realizará dos pequeños orificios en el borde más externo de la parte exterior de su ojo (donde normalmente se colocan las lentes de contacto) mediante láser. Este procedimiento asegura que el líquido fluya correctamente desde la cámara posterior hacia la cámara anterior de su ojo y evitar un aumento de la presión intraocular después de la cirugía ICP V2.0. Normalmente, el médico aplicará gafas anestésicas y realizará pequeñas aberturas en la esclerótica de su ojo (donde normalmente se usan las lentes de contacto). Este procedimiento no afecta su capacidad para conducir de regreso a casa, pero debe conformarse con su médico.

Después de la cirugía

Después de la cirugía, su médico le recetará gotas oftálmicas, se le recitarán gotas oftálmicas para su ojo. Es importante que siga todas las instrucciones relacionadas con la medicación. Su médico le indicará cuándo debe suspender el uso de estos medicamentos antes de salir de la clínica.

El día de la cirugía

El día de la cirugía, se aplicarán gotas en sus ojos para dilatar la pupila (la parte negra del ojo). Una vez que la pupila está completamente dilatada, su médico le administrará gotas anestésicas y/o una inyección con medicación anestésica en el ojo, lo que le ayudará a permanecer cómodo durante la cirugía. Después de esto, se iniciará el procedimiento. Su médico puede comentar diferentes opciones para anestesiarse u/o ayudarle a relajarse antes de la cirugía.

Se realizará una pequeña incisión en la córnea (la parte frontal transparente de su ojo) y se colocará la lente ICP V2.0 en la posición correcta. El tiempo total de la cirugía será de aproximadamente 10 a 30 minutos.

Después de la cirugía, su médico aplicará gotas oftálmicas una pomada y podrá cubrir el ojo con un parche o protector para su protección. Gracias a la anestesia, el procedimiento es indoloro. No conduzca usted mismo después de la cirugía. Organice con antelación qué alguien le lleve a casa.

El primer día después de la cirugía

Si su médico requiere el uso de dispositivos de apoyo de la cirugía, incluída la medición de la presión intraocular, experimentará sensibilidad a la luz o la sensación de tener algo dentro del ojo. El uso de gafas de sol puede ayudar. Es normal sentir cierta molestia o dolor leve, y su médico puede recomendarle el uso de analgésicos. Puesto que generalmente el dolor no afecta su capacidad para conducir de regreso a casa, pero debe conformarse con su médico.

Necesitará utilizar gotas oftálmicas o pomada durante aproximadamente una semana para prevenir infecciones y reducir la irritación.

IMPORTANTE: Utilice los medicamentos oftálmicos exactamente según las indicaciones de su oftalmólogo. (Sus resultados pueden cambiar.)

No: No frote los ojos, especialmente durante los primeros 3 a 5 días después de la cirugía. Si nota una disminución repentina de la visión, debe ponerse en contacto con su médico inmediatamente.

Cuidados a largo plazo

En algunos casos, la ICP V2.0 puede necesitar ser sustituida o retirada. Puede substituirse si la lente era es adecuada para su ojo o si la cirugía no fue exitosa. En otros casos, puede ser necesario remover la lente y sustituirla por una lente de contacto. En tales casos, puede implantarse una nueva lente para ayudar a corregir su visión.

Si se retira la ICP V2.0, perderá la corrección visual que proporcionaba su su visión puede no ser la misma que antes de la cirugía. Es importante seguir las recomendaciones de su médico y acudir a todas las visitas de seguimiento después de la cirugía.

Frecuencia de ir a su médico

Puede que desee hacer las siguientes preguntas para ayudarle a decidir si desea usar la ICP V2.0 solo en un lado de la cirugía u/o en ambos lados.

Hipermetropía es adecuada para usted

- ¿Qué das opciones tengo para corregir mi miopía o hipermetropía?
- ¿Tendrá que vivir mis actividades después de la cirugía y durante cuánto tiempo?
- ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía ICP V2.0 para mí grado de miopía o hipermetropía?
- ¿Cómo será mi vida después de la cirugía? ¿Cuánto tiempo tardaré en acostumbrarme a la nueva medida de la visión?
- Si la cirugía ICP V2.0 no corrige mi grado, ¿qué posibilidad existe de que mis gafas necesiten una graduación mayor que antes? ¿Podría aumentar mi necesidad de usar gafas con el tiempo? ¿Podría someterme a otro tipo de cirugía ocular para corregir mi visión?
- ¿Como es probable que la cirugía ICP V2.0 afecte mi necesidad de usar gafas o lentes de contacto a media que envejezca?
- ¿Cuál es el riesgo de que mi vista diferencie entre una lesión después de la implantación de la ICP V2.0?
- ¿Debería sometirme a la cirugía ICP V2.0 también en el otro ojo?
- ¿Cuánto tiempo tardaré en estar seguro de que estoy feliz con el resultado de la cirugía?
- ¿Qué problemas visuales podría experimentar si me implanto la ICP V2.0 solo en uno de mis ojos?

Resumen de información importante

- La cirugía ICP V2.0 proporciona una corrección permanente de su miopía o hipermetropía mientras la ICP V2.0 permanece en el ojo. La ICP V2.0 puede retirarse, si usted, perderá este beneficio de su visión puede no ser la misma que antes de la cirugía.
- La ICP V2.0 no elimina la necesidad de usar gafas para leer, incluso si nunca las ha necesitado anteriormente.
- Una vez que se establece una ICP V2.0, Debe proporcionar evidencia escrita de que su miopía o hipermetropía no ha cambiado más de 0.50 D por encima o debajo al menos a 1 año.
- La ICP V2.0 puede retirarse en periodos de tiempo muy cortos, pero debe esperar antes de someterse a otra cirugía.
- Como todos las lentes, la ICP V2.0 conlleva riesgos. Es importante leer y comprender toda la información antes de tomar una decisión.
- Otras opciones para corregir su visión incluyen gafas, lentes de contacto y cirugías como RK, PRK y LASIK.
- Antes de considerar la cirugía ICP V2.0, usted debe:
 - a. someterse a un examen oftalmológico completo,
 - b. hablar con al menos un profesional de la salud visual acerca de la cirugía ICP V2.0, especialmente sobre los posibles riesgos, riesgos y complicaciones. También debe hablar sobre el tiempo necesario para la recuperación después de la cirugía.

Compatibilidad con Resonancia Magnética:

La LIO implantada no contiene componentes metálicos y es segura, sin potencial de interacción con el campo de Resonancia Magnética (RM) LIO es segura para la obtención de imágenes por resonancia magnética (IRM) con intensidad de campo magnético de 1.5 y 3.0 Tesla.

Vida útil esperada y seguridad necesario

LIO normalmente dura toda la vida del paciente. No obstante, si experimenta cualquier deterioro en la calidad de su visión, consulte a su oftalmólogo para una evaluación y tratamiento adicionales. Su oftalmólogo le indicará los intervalos de seguimiento necesarios en función de su estado de salud.

Notificación de incidentes graves

Cualquier incidente grave que ocurra en relación con la lente intracutánea deberá notificarse a su médico (en primera instancia), al representante de EYEOL LLC y a la FDA, U.S. FDA, LIO.

Acerca de este documento:

Su oftalmólogo ha realizado la cirugía refractiva e implantado la lente intracutánea (LIO) en su ojo. Después de la cirugía, se le ha dado esta información para que pueda entender mejor su experiencia y cómo cuidar su ojo. Esta información es para su atención médica en caso de emergencia. El enlace proporcionado en la tarjeta de implente le permitirá acceder a las actualizaciones más recientes sobre la LIO.

MFG/MCD/2020/006163

EYEOOL LLC LIMITED
EYEOL INC., 10000
Durand, Bedfordshire, US, Boscabe Road,
Reno United States of America
Tel: +44 (0) 1582 477 002
Fax: +44 (0) 1582 467 009
Email: info@eyeoool.co.uk
Sitio web: www.eyeoool.co.uk

RUEPER
Representante europeo
OBELIS S.A.
160, General Wharf, 53
10010 Bruxelles, Bélgica
Tel: +32 272.29.59.54
Fax: +32 272.32.70.63
Correo electrónico: mail@obelis.net
Sitio web: www.obelis.net

CE
2400